



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0000709-07.2025.5.05.0192**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 01/07/2025

Valor da causa: R\$ 61.345,25

Partes:

RECLAMANTE: ANA CLARA WALTER LOPES

ADVOGADO: EVANLUCY LIMA DA SILVA

ADVOGADO: FABIO LIMA DA SILVA

RECLAMADO: ATENTO BRASIL S/A

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

PERITO: MARCO ALESSANDRO FOLTRAN



Dr. Marco Foltran

Fls.: 2

LAUDO MÉDICO PERICIAL - PSIQUIATRIA

AUTORIDADE REQUISITANTE:

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Trabalho de Feira de Santana

PROCESSO:

ATOrd 0000709-07.2025.5.05.0192

RECLAMANTE: ANA CLARA WALTER LOPES

RECLAMADO(A): ATENTO BRASIL S/A

DATA E LOCAL DA PERÍCIA:

Perícia Realizada em consultório no Fórum 2 de Julho em Salvador/BA.

METODOLOGIA E LÓGICA UTILIZADOS:

Análise da atividade laboral, anamnese, exame psicopatológico e físico, análise de documentos médicos e não-médicos dos autos e documentação complementar trazida pelo reclamante no ato pericial avaliados à luz da literatura médica baseada em evidência pertinente ao caso.

Utilização da metodologia proposta pelo grupo de saúde mental e psiquiatria do trabalho (SAMPO) do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP.

Utilização dos padrões das Resoluções CFM nº 1.851/2008 , nº 2.183/2018, 2323 de 2022 e 2430/2025.

Utilização da metodologia de graduação de concausas proposta pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira.

O magistrado não delega ao Perito a investigação de matéria fática, cabem as partes trazerem as provas que desejam que o perito as analise.

OBJETO DA PERÍCIA:

a fim de se verificar doença ocupacional ou acidente e o nexo causal com o labor, externando se há lesão e em caso positivo, suas repercussões.

HISTÓRICO:

Antes de trabalhar na reclamada a parte reclamante trabalhou:

EMPRESA	DATA	FUNÇÃO
Limpesim Com Prod	19/05/2022 a 02/07/2022	Consultor vendas

Após deixar a reclamada:

EMPRESA	ADMISSÃO	FUNÇÃO
atakarejo	11/2025	Operador

Na reclamada:

ADMISSÃO	ÚLTIMO DIA TRABALHADO	TÉRMINO DO CONTRATO
14/09/2022		19/02/2025 (estava afastada)

Função exercida:

JORNADA DE TRABALHO	FUNÇÃO EXERCIDA
6h20 com 3 pausas	Especialista relacionamento cliente I

Segundo relato do periciado, seu trabalho consistia em:



Ergonomia: Presencial 3 meses, depois Home office.
Gravida voltou para presencial. Atendendo clientes da reclamada.

NR-17 - 17.6. Organização do trabalho

17.6.1. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.

HISTÓRIA DA DOENÇA OU ACIDENTE:

A periciada é mulher jovem, atualmente com 23 anos de idade, ensino médio completo, em união estável, mãe de uma criança com um ano e oito meses, residindo com o companheiro e a filha. Seu contexto socioeconômico é simples, porém estável, com forte apoio familiar restrito ao núcleo doméstico e familiares próximos.

Nega prática regular de esportes ou hobbies, descrevendo rotina predominantemente doméstica, tanto antes quanto após o afastamento laboral. Não há relato de envolvimento social ampliado ou rede social extrafamiliar relevante, o que é compatível com a fase atual de maternidade recente.

Do ponto de vista da história de saúde pregressa, apresenta antecedentes clínicos relevantes, porém heterogêneos e não diretamente relacionados ao quadro psíquico atual.

Relata internações prévias por dengue e pielonefrite, cirurgia bariátrica realizada em dezembro de 2020, adenoidectomia em 2018 e um traumatismo cranioencefálico em 2022, com necessidade de internação em UTI e sequela persistente de anosmia e ageusia.

Apesar da gravidade do evento neurológico, não descreve sequelas cognitivas, comportamentais ou emocionais associadas, tampouco acompanhamento neurológico ou psiquiátrico contínuo após o episódio.

Nega histórico de violência, abuso, perdas afetivas relevantes ou conflitos familiares significativos.

Nega dependência química, tabagismo, etilismo ou uso de drogas ilícitas.

Não há história patológica familiar conhecida para transtornos mentais. A personalidade pré-mórbida, conforme relato, era funcional, sem traços de instabilidade emocional, impulsividade ou dificuldade adaptativa marcante. Nega transtornos mentais prévios, exceto episódio isolado de sintomas ansiosos em 2022, descritos como leves, autolimitados e sem necessidade de tratamento formal.

No campo psicoterápico, realizou acompanhamento psicológico em 2020, relacionado exclusivamente ao processo de cirurgia bariátrica, sem continuidade ou indicação de transtorno psiquiátrico à época. Até o início do quadro atual, não fazia uso de psicofármacos e não estava em acompanhamento psiquiátrico regular.

Em relação à história laboral e organização do trabalho, a atividade exercida é descrita como possuindo estresse laboral inerente e conhecido, embora, na prática concreta, não se identifiquem fatores clássicos de sobrecarga organizacional.

A própria avaliação psicossocial estruturada não demonstrou desequilíbrios relevantes. No modelo Demanda–Controle–Suporte Social (DCSQ), não houve evidência de alta demanda psicológica associada a baixo controle ou baixo suporte. Ao contrário, refere carga de trabalho compatível, prazos e ritmo adequados, autonomia para tomada de decisões e utilização de habilidades, bem como suporte satisfatório de colegas e supervisores.

No modelo de Esforço–Recompensa (ERI-Q), nega desequilíbrio, reconhecendo esforço proporcional às demandas e recompensa adequada em termos financeiros, de reconhecimento e oportunidades.

Também nega comprometimento excessivo, não apresentando padrão de hiperfoco, dificuldade de desligamento ou assunção exagerada de responsabilidades.

Recebeu treinamento adequado, não laborava em turnos noturnos ou alternados, não realizava jornadas excessivas além de horas extras regularmente pagas e não relata problemas com clientes, chefia ou cultura organizacional. Nega assédio moral ou sexual e confirma a existência de ouvidoria, embora não tenha registrado queixas formais.

O elemento central e singular da narrativa laboral refere-se ao período pós-licença maternidade. A periciada entrou em licença após o nascimento da filha em 25/04/2024, permanecendo afastada até agosto de 2024. Ao retornar ao trabalho, em setembro de 2024, passou a vivenciar situação descrita como “ócio forçado”: comparecia diariamente à empresa, registrava o ponto, porém não tinha seus acessos liberados, permanecendo sem atribuições efetivas, sem tarefas e sem perspectiva clara de reintegração funcional. Essa condição perdurou de forma contínua, segundo relato, até o afastamento médico, sem que houvesse solução administrativa. A vivência subjetiva associada a esse contexto foi de frustração, inutilidade, conflito interno e sofrimento psíquico, especialmente pelo fato de ter deixado uma filha pequena em casa “para nada”, como verbaliza.

Os sintomas tiveram início entre setembro e outubro de 2024, temporalmente compatíveis com o retorno ao trabalho. Descreve aperto no peito, vontade frequente de chorar, sensação de fraqueza, ansiedade difusa e sofrimento emocional persistente.

Em 28/10/2024 iniciou acompanhamento psicológico, mantido até 21/02/2025. Em 11/11/2024 houve emissão de atestado por psicóloga. Diante da persistência dos sintomas, foi encaminhada para psiquiatria, iniciando uso de sertralina em 17/12/2024.

Foram estabelecidos os diagnósticos de Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1) e Transtorno de Adaptação (CID F43.2), conforme relatórios médico e psicológico. Em 17/11/2024, a própria médica do trabalho da reclamada procedeu ao afastamento laboral e encaminhamento ao INSS, o que constitui elemento objetivo relevante na cronologia do adoecimento.

Durante o período de afastamento, a rotina passou a ser centrada no ambiente domiciliar, com cuidados da filha, sem atividades laborais externas. Refere melhora progressiva do quadro em relação à época em que estava comparecendo ao trabalho sem exercer funções, o que sugere redução do fator estressor identificado. Atualmente, não se encontra em tratamento ativo, referindo estabilidade clínica.

Esteve sob o benefício do INSS:

ESPÉCIE	PERÍODO	REABILITAÇÃO	DATA
31	11/03/2024 a 24/04/2024 pielonefrite		
31	20/01/2025 a 26/02/2025 psiquiátrico		

CAT

EMISSION	DATA	DATA DO ACIDENTE	DESCRIÇÃO

Afastamentos

DATA	PERÍODO	CID 10
------	---------	--------

Data	Início da Licença	Fim da Licença	Dias Afastados	Cid
05/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	1	R10.2 - Dor pélvica e perineal
08/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	2	N39 - Outros transtornos do trato urinário
16/02/2024	07/02/2024	13/02/2024	7	000.0 - Motivo não declarado
04/03/2024	14/02/2024	17/02/2024	4	N11.0 - Pielonefrite não-obstrutiva crônica associada a refluxo
28/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	1	O23 - Infecções do trato geniturinário na gravidez
05/02/2024	31/01/2024	31/01/2024	1	000.0 - Motivo não declarado

Detalhamento do afastamento: Em 31/01/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID 000.0; Em 01/02/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID R10.2; De 02/02/2024 a 03/02/2024 – PERÍODO TRABALHADO; Em 04/02/2024 – FOLGA; De 05/02/2024 a 06/02/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID N39; Em 07/02/2024 a 13/02/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID 000.0; Em 14/02/2024 a 17/02/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID N11.0; Em 18/02/2024 – FOLGA; Em 19/02/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID 000.0; Em 20/02/2024 – PERÍODO TRABALHADO; De 21/02/2024 a 22/02/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID O26.8; De 23/02/2024 a 24/02/2024 – PERÍODO TRABALHADO; Em 25/02/2024 – FOLGA; Em 26/02/2024 – ATESTADO MÉDICO – CID O23; De 27/02/2024 a 28/02/2024 – PERÍODO TRABALHADO; Em 29/02/2024 – 16º dia de afastamento – encaminhamento.	Detalhamento do afastamento: Em 02/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID 000.0; Em 03/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID 000.0; De 04/10/2024 a 05/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID J06.9; Em 06/10/2024 – PERÍODO TRABALHADO; Em 07/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID J00; Em 08/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID N39.0; Em 09/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID N39; De 10/10/2024 a 11/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID J06.9; De 12/10/2024 a 13/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID R42; De 14/10/2024 a 15/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID R42; De 16/10/2024 a 22/10/2024 – PERÍODO TRABALHADO; De 23/10/2024 a 24/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID R11; De 25/10/2024 a 26/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID R11; Em 27/10/2024 – FALTA INJUSTIFICADA; Em 28/10/2024 – ATESTADO MEDICO – CID K52.9; De 29/10/2024 a 30/10/2024 – FALTA INJUSTIFICADA; De 31/10/2024 a 02/11/2024 – PERÍODO TRABALHADO; De 03/11/2024 a 04/11/2024 – ATESTADO MEDICO – CID K29.1; De 05/11/2024 a 10/11/2024 – PERÍODO TRABALHADO; Em 11/11/2024 – FALTA INJUSTIFICADA; De 12/11/2024 a 16/11/2024 – ATESTADO MEDICO – CID B30; De 17/11/2024 – 16º dia de afastamento – encaminhamento.
---	--

RELATÓRIOS

ASO inapta

EXAME FÍSICO:

Paciente deu entrada no consultório caminhando por seus próprios meios, com marcha normal e sem auxílio de aparelhos. Está em bom estado físico e nutricional, apresentando idade física compatível com a idade cronológica. Peso 90 kg e altura 1,80 m.

O EXAME PSICOPATOLÓGICO DA PARTE PERICIADA

Domínio Avaliado	Descrição Clínica Observada
Aspecto (Aparência)	Apresenta-se com aparência normal, vestida adequadamente para idade e condição socioeconômica. Higiene pessoal preservada.
Postura / Atitudes	Cooperante, responde adequadamente a todas as perguntas.
Nível de Consciência	Quantitativa e qualitativa sem particularidades Curso de pensamento normal, com respostas coerentes e em velocidade compatível.
Orientação	Orientada no tempo e no espaço.
Atenção	Vigilância, tenacidade e concentração preservadas.

Domínio Avaliado	Descrição Clínica Observada
Memória	Sem dificuldades para registrar, fixar, reter, evocar ou reconhecer estímulos e experiências.
Inteligência Raciocínio	Raciocínio lógico preservado e compatível com o nível socioeducacional.
Comportamento Conduta	Sem ansiedade, frustração ou tensão psicomotora evidente.
Sensopercepção Ilusões	Sem alterações observadas.
Sensopercepção Alucinações	Sem alterações observadas.
Pensamento – Curso e Conteúdo	Ideias em sequência lógica, sem aceleração ou bloqueios. Conteúdo e curso preservados.
Linguagem	Boa dicção, volume adequado, discurso claro e coerente.
Conação	Atividade mental direcionada a ação sem particularidades
Pragmatismo	Preservado
Afetividade / Humor	Afetividade modulada, congruente e ressonante. Emociona-se ao relatar vivências laborais, apresenta humor algo hipotímico.
Juízo Crítico	Insight preservado. Orientada, com autopercepção preservada. Reconhece impacto cumulativo negativo de experiências laborais na autoestima e dignidade.
Funções Psicofisiológicas	Sono e apetite preservados. Mantém relacionamento afetivo funcional.

TABELA DE AVALIAÇÃO DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE (CID-10 / Modelo descritivo)

Tipo de Personalidade	Traços Presentes	Descrição Sumária
Paranoide	NÃO	Caráter desconfiado, hipersensibilidade a ofensas, tendência a interpretar intenções ocultas
Esquizóide	NÃO	Recolhimento afetivo e social; preferência por atividades solitárias; frieza emocional
Antissocial	NÃO	Irresponsabilidade persistente; impulsividade; desprezo por normas sociais; ausência de empatia
Emocionalmente Instável	NÃO	Impulsividade, instabilidade afetiva, acessos de raiva, comportamento imprevisível
Histriônica	NÃO	Afetividade superficial; dramatização; necessidade de aprovação; teatralidade
Anancástica (Obsessivo)	NÃO	Perfeccionismo; rigidez; escrupulosidade; preocupações com normas, ordem e controle
Ansiosa (Evitativa)	NÃO	Insegurança intensa; hipersensibilidade a crítica; evitação de situações novas por medo de inadequação
Dependente	NÃO	Submissão excessiva; dificuldade de tomar decisões; apego a figuras de autoridade



Dr. Marco Foltran

Fis.: 7

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

Psicóloga - Larissa Lucia da Silva Tosetto
CRP - 06/178605
Paciente: Ana Clara Walter Lopes
Data de Nascimento: 01/06/2002

ASSUNTO - Solicitação de relatório psicológico

Descrição da Demanda.

A paciente passou por atendimento psicológico no período de 28/10/2024 a 21/02/2025, com seis atendimentos realizados desde então, através da modalidade online. Desde o primeiro atendimento, vem em suas queixas o quadro de ansiedade Generalizada, com palpitação, falta de ar, mal estar geral, e não consegue seguir com sua saída de casa quando tem que ir trabalhar. Esses sintomas se apresentam no momento em que a paciente precisa sair de dentro de casa para se deslocar para o ambiente de trabalho, em seus relatos não houve manifestação desses sintomas em nenhuma outra saída fora de casa, sendo essa necessária ou não. Esse relatório foi solicitado pela Ana Clara Walter Lopes e tem por objetivo informar que a mesma deu início ao tratamento terapêutico a fim de fazer o acolhimento de seu sofrimento e apresentar seu sofrimento diante do ambiente de trabalho que inicia-se já na saída de casa para o mesmo.

Procedimento.

Para elaboração do documento foi informado a paciente que faríamos uma escuta mais direcionada a suas vivências dentro do ambiente de trabalho, visto que em atendimentos anteriormente ocorridos ao pedido do documento, a paciente já vinha trazendo a questão do trabalho como o gatilho para os sintomas de ansiedade que vem apresentando. Os atendimentos aconteceram uma vez a semana, ambas em ambiente isolado, garantindo o sigilo de nossa conversa, as sessões duravam em torno de 40 a 60 min. Após esse momento de orientação inicia-se a escuta e entendimento das suas queixas, e a relação das mesmas com seu ambiente de trabalho que é quando a paciente começa a contar que começou a desenvolver esses sintomas de ansiedade, que começaram após seu retorno da licença maternidade, questionada se esses sintomas apareciam em outros momentos do seu dia e em saídas com propósito diferente além do trabalho, ela trouxe que não, que em outros eventos, compromissos externos ou afazeres não tem nenhum sintoma de ansiedade.



PJE Documento assinado eletronicamente por FABIO LIMA DA SILVA, em 01/07/2025, às 00:34:43 - 01992a

Diante desses relatos então houve uma busca por entender melhor como era esse ambiente de trabalho, o que fazia e como era a dinâmica dentro da empresa e principalmente com ela, foi dito por ela que o problema na empresa começou quando ela se descobriu grávida, pouco tempo após entrar na empresa (empresa essa que é do ramo de telemarketing), que notou que seus superiores mudaram o tratamento com ela, a tratando com indiferença, com mais cobranças, conta também que durante a gestação passava muito mal e em decorrência disso, tinha muitas ausências do trabalho e com isso relata que havia muitas cobranças para uma assiduidade e cumprimento de metas, assim como sua contribuição para com a equipe de trabalho para cumprimento das mesmas, conta que na sua percepção, a empresa não acreditava serem reais, verdadeiros os documentos médicos apresentados, que seu mal-estar na gestação não era real, a cobrando de ir trabalhar mesmo informando sua situação e apresentando atestados médicos e que notou que outra gestante passava por situações semelhantes a sua, vendo assim que a questão não era diretamente com ela, pessoal, e sim condicional, relacionado diretamente aos atestados apresentados na gravidez. Com o afastamento para licença maternidade e retorno ao trabalho, durante o expediente de trabalho não permitiram-na ter acesso ao sistema utilizado pela empresa para realizar suas tarefas, sistema esse utilizado e por funcionários de funções iguais a dela e com isso durante o período de seis horas que fica na empresa não consegue realizar as tarefas pertinentes a seu trabalho e isso a deixa com um mal estar ainda maior, o que a vem levando a não conseguir sair de casa para trabalhar, que só de se arrumar com a ideia de ir para a empresa, ela não consegue sair de casa, e começa a ter a palpitação e falta de ar, precisando em muitos momentos recorrer a um pronto socorro para buscar um atestado médico para apresentar a empresa. Trouxe também que no momento está afastada da empresa pelo médico do trabalho, aguardando passar por Perícia junto ao INSS para concretizar o afastamento pelo órgão.

Análise.

Diante de tudo que foi dito a ela e de intervenções ditas e passadas a ela, não houve nenhum efeito, os sintomas continuavam sem manifestando a cada tentativa da mesma de ir trabalhar, que já tinha tentando pôr em prática tudo que foi passado a ela nas terapias e que nada tinha dado resultado.

E dado a gravidade dos relatos trazidos por ela e sua instabilidade emocional, foram passadas duas recomendações a paciente, que procurasse um psiquiatra para em conjunto com a terapia ajuda-la com o auxílio de medicação. Na última consulta feita com a paciente, ela trouxe que com o afastamento conseguido da empresa estava melhor, que os sintomas não estavam mais



PJE Documento assinado eletronicamente por FABIO LIMA DA SILVA, em 01/07/2025, às 00:34:43 - 01992a

Fis.: 67

se manifestando já que estava em casa, tranquila, cuidando da filha e não precisando ir na empresa e que a medicação estava ajudando com esses sintomas.

Conclusão.

Diante dos relatos trazidos pela paciente, ficou claro que o ambiente de trabalho está causando mal estar, pânico, palpitação e falta de ar só de pensar em sair de casa com o intuito de ir para essa empresa, o que levou ao seu afastamento médico da mesma.

Jundiaí, 25 de fevereiro de 2025.

Larissa Lúcia da Silva Tosetto
CRP 06/178605

Fis.: 68

Nome: ANA CLARA WALTER LOPES
CPF: 841.885.375-15

Data e hora: 20/01/2025 - 16:17:08 GMT-3

RELATÓRIO MÉDICO

Relato para os devidos fins que a paciente ANA CLARA WALTER LOPES, portadora do CPF: 841.885.375-15, iniciou seguimento médico sob meus cuidados em 17/12/2024, descrevendo sintomas ansiosos desde 2022, com piora há 4 meses, associado a humor hipotímico, após retorno ao trabalho posterior a licença maternidade, sendo estabelecido hipótese diagnóstica, de acordo com o CID 10: F41.1 +F43.2, e iniciado tratamento com sertralina 50 mg/dia, além de terapia. No momento, não apresenta previsão de alta ambulatorial.

Atenciosamente,

Paciente autoriza divulgação do CID.



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code
Endereço: 155 Rua João Góes Jr.
Assinado digitalmente por Danielle Ferreira Lonchias - CRM 214618 SP
Token (Farmácia): 1h75FU - Código de desbloqueio (Paciente): 5802

*Para validar assinaturas dentro do documento, acesse <https://validador.memed.com.br/> Token: 1h75FU

PCMSO e7f9954

LTCAT

Quesitos • Impugnação • Estratégias Individualizadas • Consulta Médico-pericial • Pareceres



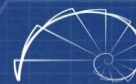
@drmarcofoltran



mfoltran@uol.com.br



85 991 172 586



Dr. Marco Foltran

EPIs	PGR 06014d8, 6fe6ee6
AET/ AEP faa01c4, c891eb5, 71d898e, 387d03a, 32e3373, 197b557, 34b4d42, f46c69e, 19d70b1, 588a3c9, e27f730, 393341d, e6541e3, 4a24756, 6ecc226, 93527a3, 85c80a5	PPRA df2f1c0, 4ce9f51,

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS:

Considerando:

a análise da história do periciado analisada no plano longitudinal (ao longo do tempo) e não transversal (apenas um momento)
os sintomas relatados em anamnese
relatórios dos psicólogos e psiquiatras
dados do exame psicopatológico realizado
os critérios diagnósticos do DSM V
e análise das provas juntadas nos autos,
é o parecer do perito que o periciado se encaixa no diagnóstico de:
F432 TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO COM SINTOMAS DEPRESSIVOS

Em Psiquiatria, as discordâncias diagnósticas são comuns até mesmo entre renomados psiquiatras. Assim, outra(s) hipótese(s) diagnóstica(s) é(são) possível(is), desde que bem fundamentada(s) em anamnese e exame psíquico do paciente.

DISCUSSÃO – LÓGICA MÉDICO-PERICIAL SOBRE O CASO:

Do ponto de vista técnico-pericial, a análise do nexa exige especial atenção ao caráter específico do fator alegado.

Não se trata de sobrecarga, metas abusivas, assédio ou pressão por desempenho, mas de uma situação de esvaziamento funcional e inutilização do posto de trabalho, fenômeno descrito na literatura como “ócio forçado” ou “inatividade imposta”, potencialmente gerador de sofrimento psíquico, sobretudo em indivíduos em fase de reorganização identitária, como o retorno da licença maternidade.

Esse tipo de estressor não é inerente à função em si, mas decorre da forma como o trabalho foi organizado naquele período específico.

Entretanto, é imprescindível ressaltar que a caracterização desse ócio como fato objetivo depende de comprovação documental e/ou testemunhal nos autos, tais como registros de acesso, comunicações internas, ordens de serviço ou outros elementos que confirmem a ausência deliberada de atribuições. Na ausência dessa comprovação, o relato permanece no campo subjetivo da anamnese, que, embora coerente e temporalmente consistente, não se equipara automaticamente a prova material.

Assim, sob a ótica médico-pericial, caso reste comprovado nos autos que a periciada, após o retorno da licença maternidade, foi mantida em situação prolongada de inatividade forçada, sem tarefas e sem justificativa técnica ou administrativa, tal condição pode ser reconhecida como fator contributivo relevante para o desencadeamento e manutenção do quadro ansioso-adaptativo.

Nessa hipótese, o trabalho não se configura como causa única, mas como concausa de grau II, atuando de forma moderada, em interação com fatores pessoais legítimos, como a maternidade

recente, a vulnerabilidade emocional do período puerperal tardio e a reorganização da rotina familiar.

Por outro lado, na ausência de comprovação objetiva do alegado ócio forçado, o nexos causal ou concausal não se sustenta do ponto de vista técnico, devendo o adoecimento ser compreendido como decorrente predominantemente de fatores pessoais e adaptativos extra laborais. A conclusão pericial, portanto, é necessariamente condicionada à prova do contexto organizacional descrito, mantendo-se a coerência com a cronologia clínica, a resposta ao afastamento e os diagnósticos estabelecidos.

SOBRE A VISITA IN LOCO:

No caso em análise, a vistoria ao posto de trabalho torna-se inócua, uma vez que se trata de análise de fatores psicossociais ocorridos no passado, não apuráveis em uma vistoria atual no posto de trabalho.

SOBRE O ALEGADO ASSÉDIO MORAL:

O assédio moral caracteriza-se por condutas abusivas, repetitivas e sistemáticas, com o objetivo de desestabilizar psicologicamente o trabalhador, expondo-o a situações humilhantes, constrangedoras ou vexatórias.

Trata-se de uma violência silenciosa, muitas vezes imperceptível em atos isolados, mas que, em conjunto, gera sofrimento psíquico e físico relevante, com impacto direto na saúde mental, produtividade e relações sociais da vítima.

Essas ações geralmente partem de superiores (assédio vertical descendente), mas podem ocorrer entre colegas (horizontal) ou de subordinados para chefes (vertical ascendente), e são agravadas por contextos de competitividade excessiva, autoritarismo, racismo, xenofobia, ou pressão por metas inalcançáveis.

O assédio moral compromete não só a saúde do trabalhador, mas também o ambiente organizacional, provocando queda de produtividade, aumento do absenteísmo, isolamento da vítima, rupturas familiares e até desligamentos "voluntários" forçados.

A **comprovação pericial é complexa**, pois o dano decorre da repetição de atos muitas vezes sutis. O perito deve avaliar a **compatibilidade entre o quadro clínico e a narrativa apresentada**, identificando a presença ou ausência de fatores extra laborais relevantes. Na dúvida, o juízo deve ser amparado por testemunhos e provas documentais para verificar a verossimilhança do nexos.

O assédio moral não é uma doença per se, fugindo desta forma, ao escopo médico, portanto a confirmação de alegado assédio por meio de eventual oitiva de testemunhas deve ser realizada em juízo, onde há compromisso de se dizer a verdade, frente a profissional com maior competência para avaliar a validade das possíveis provas testemunhais.

Deve-se lembrar que o assédio moral é de difícil comprovação, pois, conforme destacado acima, ele surge a partir de um conjunto de comportamentos que, se analisados separadamente, nada significam, mas, se analisados sob a ótica da continuidade, de atos programados, configuram o assédio moral.

Ao perito cabe informar a compatibilidade do quadro clínico com a alegação de assédio moral e com o estudo de fatores extra laborais e, na ausência destes concluir pelo fator laboral quando da ausência de outros fatores ambientais causadores do agravo.

Situações estressoras alegadas que sugerem assédio moral (em azul):

Restrição de comunicação	Sobrecarga	Privação de informações
Ignorar	Tarefas perigosas	Limitação da carreira profissional
Interrupções contínuas	Impedir a segurança	Danos na imagem
Trabalha contra os princípios	Danos econômicos	Pressão
Avaliação tendenciosa	Proibição de comunicação com colegas	Redução de prazos
Inatividade forçada	Subvalorização do desempenho	Modificação de responsabilidade
Trabalhos bobos	Acusações confusas	Esforço de desvalorização
Tarefas abaixo da competência	Acusação sistemática	Desmoralizar
Tarefas de rotina	Erros de amplificação	Enganar
Humilhação	Uso disciplinar ameaçador	Monitoramento perverso
Medidas de isolamento	Distorção de comunicação	Insinuações sexuais
Desestabilização	Desprezo	Ridículo
Provocando	Criticar a vida pessoal	Rumores
Ameaçando pessoalmente	Ameaças escritas	Opressão física
Gritando		

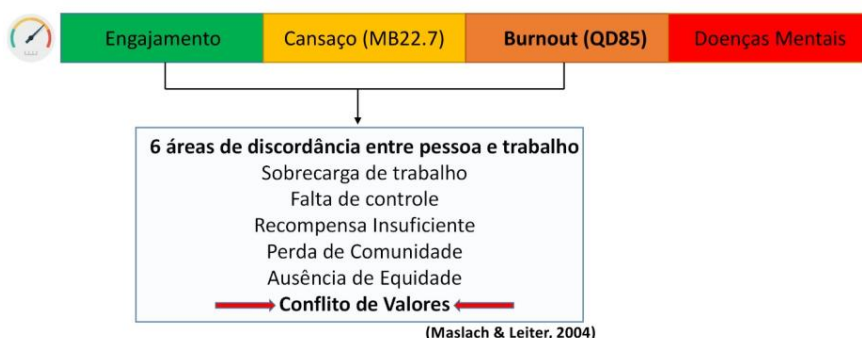
Assédio Fonte: Adaptado de Fidalgo e Piñuel (2004). Individual Questionnaire on Psychoterror, Denial, Stigmatization and Rejection in Social Organizations, escala Cisneros.

CONFLITO DE VALORES NA SAÚDE MENTAL

Há sugestão de fator estressor a partir da discordância pessoa x trabalho, NOTADAMENTE PERDA DE COMUNIDADE, DE EQUIDADE, gerando conflito de valores implicados na saúde mental.

Conflito de valores x saúde mental

Estresse exclusivamente relacionado ao trabalho



CONSIDERAÇÕES SOBRE SIMULAÇÃO:

Na avaliação psiquiátrica, um dos elementos a serem considerados pelo médico perito é a possibilidade da simulação de sintomas e sinais clínicos de transtornos mentais ou de outra ordem. Simulação é conceituada pela Organização Mundial de Saúde como "a produção

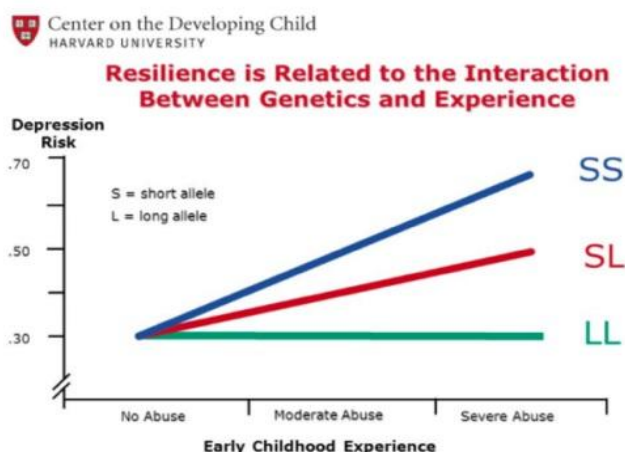
intencional ou invenção de sintomas ou incapacidades tanto físicas quanto psicológicas, motivadas por estresse ou incentivos externos".
Na avaliação presencial, o reclamante não apresentou quaisquer sinais de tentativa de simulação consciente ou inconsciente.

DO PAPEL DA GENÉTICA NO ADOECIMENTO PSÍQUICO:

Resultados de pesquisas dos últimos 30 anos demonstraram que a hipótese anterior simples da existência de genes de grande efeito, que causam diretamente doenças psiquiátricas, era falsa. Os dados apontam para o envolvimento de múltiplas variantes de genes como os fatores responsáveis de risco genético, que agem e interagem uns com os outros e com o ambiente, em uma complexa "dança" de desenvolvimento para produzir indivíduos com alto e baixo risco de doença. É esse tipo de complexidade que os pesquisadores procuram abordar agora.

Um estudo interessante foi realizado em 2003 na Harvard University, relacionando a presença de alelos específicos com o desenvolvimento da depressão. Note no quadro abaixo a correspondência entre o aparecimento de depressão a partir de um fator estressor (eixo Y) dependendo do alelo (LL, SL, SS). Fica claro que pessoas com alelo LL, ainda que submetidas ao agente estressor, não desenvolvem a doença, enquanto as pessoas com alelos SL e SS, sim.

Isto mostra que o desenvolvimento da depressão e outros transtornos psiquiátricos estão sim, ligado à genética, em interação com fatores ambientais.



Caspi, 2003

Uma reflexão importante que se deve fazer é que, num universo de pessoas sujeitas à mesma pressão num determinado labor, algumas desenvolverão doença psiquiátrica, como a depressão ou ansiedade, por exemplo, enquanto a maioria não.



SOBRE O MOMENTO ATUAL

Quesitos • Impugnação • Estratégias Individualizadas • Consulta Médico-pericial • Pareceres



@drmarcofoltran



mfoltran@uol.com.br



85 991 172 586



Dr. Marco Foltran

Atualmente, observa-se uma epidemia silenciosa de adoecimento mental no trabalho, substituindo antigos riscos físicos por quadros crescentes de ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos.

Se no passado as principais preocupações envolviam mutilações e acidentes, hoje o foco deslocou-se para o sofrimento psíquico causado por ambientes organizacionais adoecedores. Tal como outrora se superou a negligência com a segurança física, é imperativo reconhecer que a saúde mental exige o mesmo compromisso ético e jurídico por parte dos empregadores.

Quando não há histórico anterior ou fator estressor extra laboral relevante e surgem evidências de um ambiente laboral hostil, é legítimo considerar o trabalho como fator contributivo no adoecimento mental do empregado.

SOBRE A COERÊNCIA TEMPORAL

Após análise da dinâmica do trabalho, dos documentos, relatórios e exame psicopatológico temos que a parte periciada adoeceu durante o labor.

Há coincidência temporal, mas isso é suficiente?

Há que se diferenciar um trabalhador que tem uma doença de um doente que tem um trabalho

SOBRE A FUNÇÃO DA PARTE PERICIADA

Também faz parte da análise a consideração de que determinados labores têm carga estressora maior que outros, inerente à execução da função.

Por exemplo, um médico que trabalhe na emergência de um centro de referência de trauma provavelmente tem uma carga estressora - inerente ao escopo de seu trabalho - muito maior que um dermatologista que atende em consultório. Da mesma forma, é lógico considerar que um funcionário de empresa privada em um segmento competitivo cuja remuneração é variável em função de metas atingidas, tem uma carga de cobrança maior que um funcionário público com ganho fixo sem metas objetivas.

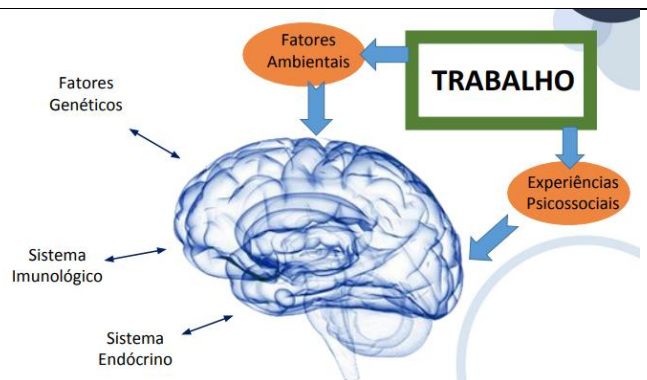
A função da parte periciada É reconhecida pela literatura como inerentemente estressora.

SOBRE O NEXO EM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO

Estudos de abrangência mundial, mostram que desempregados e aposentados se suicidam mais que pessoas empregadas, por exemplo. Dizer simplesmente que o trabalho adoece o homem é raso. *Trabalhar nos protege de 3 males: da fome, do tédio e da necessidade*, como dizia Voltaire.

A Atribuição do nexu **causal** somente é possível quando o labor é causa **necessária e suficiente** para o adoecimento, mas tal conclusão não é possível. A literatura médica aponta claramente que fatores próprios do indivíduo estão envolvidos na gênese das doenças psiquiátricas.

Com relação ao nexu **concausal**, há que se considerar que para tal atribuição, o labor, embora não suficiente, seria causa contributiva para o adoecimento.



Não há dúvidas de que há também fator psíquico próprio envolvido na gênese da doença.

Também se devem considerar os fatores estressores ambientais, sejam estes, extra laborais ou laborais. NÃO FORAM identificados fatores estressores ambientais extra laborais neste caso.

Dito isso, num juízo de probabilidade e possibilidade, creio que as rotinas estressantes do labor, notadamente o ócio forçado, foi fator contributivo no adoecimento do periciado, no sentido de servir como “gatilho” para o desenvolvimento da doença em indivíduo suscetível.

CONCLUSÃO PERICIAL:

Este perito não duvida da condição de saúde da parte periciada. Por óbvio, o indivíduo periciado sempre tenderá a crer que sua doença seja devida ao labor, muitas vezes apenas por conta da coincidência temporal. Por sua vez a reclamada sempre refutará o nexos, mas o perito deve se basear na metodologia deste laudo para sua conclusão.

A análise pericial tratada aqui responde aos limites definidos pelo magistrado no objeto da perícia, quais sejam a relação de causa e efeito entre o labor e a doença e suas repercussões na capacidade laboral.

Na versão do paciente, o labor foi fator estressor, mas o mesmo fator não causaria doença na maioria da população. **Não cabe ao perito julgar se estes fatores estressores adoeceriam a maioria das pessoas, e sim identificar, segundo objeto da perícia, se neste caso específico o labor foi ou não fator contributivo e determinar a existência ou não do nexos.**

Desta forma, concluo:

Foi identificada a existência de fatores contributivos extra laborais, quais sejam: fator psíquico individual.

Foi identificada a existência de fatores contributivos laborais, quais sejam: riscos estressantes, psicossociais, organizacionais, capazes de causar a doença.

Há plausibilidade científica entre o adoecimento e os fatores contributivos laborais encontrados.

O assédio moral deve ser avaliado pelo magistrado, conforme apontado acima.

Há concausalidade (múltiplos fatores, conjugando causas relacionadas ao trabalho com outras, extra laborais).

O grau de contribuição do trabalho na doença foi moderado (grau II).

GRADUAÇÃO DE CONCAUSAS*		
1. Ausência de Concausas (A Causa é Extralaboral)		
Não ocorre o nexos causal quando o trabalho tiver atuado de forma desprezível, periférica ou indireta para o acidente ou adoecimento. O art. 21 da Lei n. 8.231/91 menciona a concausa quando o trabalho haja "contribuído diretamente" para o acidente ou doença.		
2. Presença de Concausa na Doença Ocupacional		
<i>Graus de Contribuição</i>	<i>Contribuição do Trabalho</i>	<i>Contribuição Extralaboral</i>
Grau I	Baixa/Leve	Intensa/Alta
Grau II	Média/Moderada	Média/Moderada
Grau III	Intensa/Alta	Baixa/Leve

* Classificação proposta pelo Exmo Sr. Dr. Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira

Se o trabalho atuou como fator contributivo da lesão, desencadeante ou agravante de doença pré-existente ou ainda se provocou a precocidade da doença, tem-se concausa. A concausa é outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia nem interrompe o processo causal, apenas o reforça, tal qual um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal.

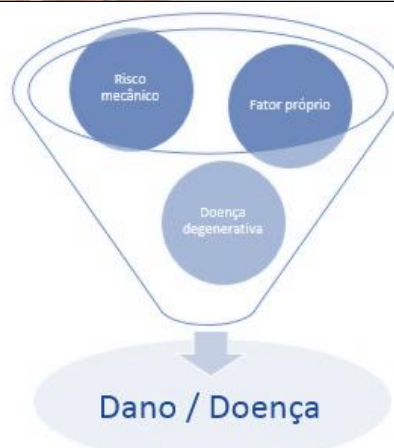
A concausa pode preexistir (antecedente), suceder (superveniente) ou agir concomitantemente (simultânea) com o acidente ou doença e pode ser discreta, moderada ou intensa.

Na concausa, temos que o labor não é isoladamente responsável pela doença.

Quando se diz que uma doença tem nexo concausal com o labor, por definição, significa que estão envolvidos no resultado final:

- múltiplos fatores;
- conjugando causas relacionadas ao trabalho;
- com outras, próprias do indivíduo ou extra laborais,

conforme vemos no exemplo hipotético ao lado:



Há coerência temporal entre a doença e a ocorrência dos fatos.

Grau e intensidade do labor são compatíveis com a produção ou agravo.

O tempo de exposição aos riscos do labor são compatíveis com a produção ou agravo.

Há comprovação com relatórios complementares.

Não há preexistência e/ou danos anteriores.

Houve melhora com o afastamento do labor, corroborando a tese do nexo

Houve incapacidade laboral temporária.

Não há incapacidade atual, com relação à repercussão atual da doença na atividade profissional, os sintomas atuais resultantes são compatíveis com a profissão anteriormente exercida.

“Estar doente não significa, necessariamente, ter incapacidade para o trabalho”

Não foram identificadas incapacidades nos domínios da cognição, mobilidade, autocuidado, relacionamento, atividades de vida e/ou participação.

Da quantificação da incapacidade segundo a WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS) – DSM V:

COGNIÇÃO (domínio 1): Avalia atividades de comunicação e de pensamento; áreas específicas avaliadas incluem concentração, memória, resolução de problemas, aprendizado e comunicação.

MOBILIDADE (domínio 2): Avalia atividades como ficar em pé, mover-se dentro de casa, ficar fora de casa e caminhar uma longa distância.

AUTOCUIDADO (domínio 3): Avalia auto higiene, vestir-se, comer e ficar sozinho.

RELACIONAMENTO (domínio 4): Avalia as interações com outras pessoas e as dificuldades encontradas devidas a uma condição de saúde.

ATIVIDADES DE VIDA (domínio 5): Avalia dificuldades com as atividades do dia a dia, isto é, aquelas que as pessoas fazem na maioria dos dias, incluindo as associadas com as responsabilidades domésticas, lazer, trabalho e escola.

PARTICIPAÇÃO (domínio 6): Avalia as dimensões sociais, tais como as atividades comunitárias, barreiras e obstáculos no mundo em torno do indivíduo, e problemas com outras questões, tais como manutenção da dignidade pessoal.

Houve perturbação na relação psíquica, na tranquilidade, sentimentos e afetos da parte reclamante em virtude do labor CONDICIONADOS à prova (documentais ou testemunhais admitidas pelo juízo) dos fatores estressores alegados.

DA INDEPENDÊNCIA TÉCNICA DO PERITO JUDICIAL

Cumpra destacar que o perito médico judicial exerce função de auxiliar da Justiça, investido de fé pública e dotado de independência técnico-científica, nos termos do Código de Processo Civil (arts. 156 a 479) e das Resoluções do Conselho Federal de Medicina.

O laudo pericial não se encontra adstrito a conclusões previamente lançadas por médicos assistentes, médicos do trabalho ou mesmo por perícias administrativas do INSS. Esses documentos têm valor probatório, mas não vinculam o juízo nem o perito judicial. A jurisprudência consolidada e a doutrina médico-legal são claras ao reconhecer a hierarquia das decisões médicas, em que o laudo pericial judicial prevalece sobre os demais, dada sua elaboração sob contraditório, imparcialidade e observância às normas processuais.

Inclusive, a Lei nº 605/1949, em seu art. 6º, § 2º, ao tratar da aceitação de atestados médicos para fins trabalhistas e previdenciários, estabelece que a decisão do médico perito da Previdência Social se sobrepõe às demais. Por analogia e em nível hierárquico superior, o perito nomeado pelo Juízo encontra-se ainda acima dessa esfera administrativa, sendo sua conclusão a que deve prevalecer para a formação do convencimento judicial.

Portanto, eventual irresignação de parte quanto à divergência entre atestados particulares, pareceres ocupacionais ou avaliações administrativas do INSS não obriga o perito judicial a justificar-se frente a esses documentos, uma vez que sua função é justamente avaliar de modo isento, imparcial e técnico, cabendo ao Juízo a apreciação final das provas.

RESPOSTA AOS QUESITOS:

OS QUESITOS QUE NÃO SE REFEREM AO OBJETO DA PERÍCIA, HIPOTÉTICOS, GENÉRICOS, QUE PEDEM OPINIÃO PESSOAL OU OS QUE SE TRATAM DE SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS AUTOS NÃO SERÃO RESPONDIDOS, DE ACORDO COM O CPC.

O magistrado não delega ao Perito a investigação de matéria fática, cabe às partes trazerem as provas que desejam que o perito as analise à luz da medicina.

Do reclamante

1. PODE O(A) SR(A). PERITO(A) CONFIRMAR, COM BASE NA ANÁLISE CLÍNICA E NOS DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS (LAUDOS PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS), SE A RECLAMANTE É PORTADORA DAS PATOLOGIAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (CID F41.1) E TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO (CID F43.2)?

SIM. CONSTA DOS RELATÓRIOS MÉDICO E PSICOLÓGICO A ATRIBUIÇÃO DIAGNÓSTICA DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (CID F41.1) E TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO (CID F43.2). NÃO OBSTANTE, NA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA PERICIAL, CONSIDERANDO A ANÁLISE LONGITUDINAL, A ANAMNESE, O EXAME PSICOPATOLÓGICO E OS CRITÉRIOS DSM-5, O DIAGNÓSTICO SINTETIZADO NESTE LAUDO FOI F43.2 (TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO, COM SINTOMAS DEPRESSIVOS), RESSALTANDO-SE QUE DISCORDÂNCIAS DIAGNÓSTICAS SÃO POSSÍVEIS EM PSIQUIATRIA, DESDE QUE BEM FUNDAMENTADAS NO EXAME PSÍQUICO E NA HISTÓRIA CLÍNICA.

2. QUEIRA O(A) NOBRE EXPERT DESCREVER O QUADRO CLÍNICO DA RECLAMANTE, DETALHANDO OS SINTOMAS, A SEVERIDADE E OS TRATAMENTOS A QUE FOI SUBMETIDA, INCLUINDO AS MEDICAÇÕES PRESCRITAS.

CONFORME HISTÓRIA CLÍNICA DESCRITA NO LAUDO, OS SINTOMAS TIVERAM INÍCIO ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, APÓS O RETORNO DA LICENÇA-MATERNIDADE, COM ANSIEDADE DIFUSA, APERTO NO PEITO, SENSAÇÃO DE FRAQUEZA, VONTADE FREQUENTE DE CHORAR E SOFRIMENTO EMOCIONAL PERSISTENTE. INICIOU ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO EM 28/10/2024, MANTIDO ATÉ 21/02/2025, HAVENDO EMISSÃO DE ATESTADO PSICOLÓGICO EM 11/11/2024. FOI ENCAMINHADA À PSIQUIATRIA, COM INÍCIO DE SERTRALINA EM 17/12/2024. DO PONTO DE VISTA FUNCIONAL, O LAUDO RECONHECE QUE HOVE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA NO PERÍODO DE AFASTAMENTO/ BENEFÍCIO, E QUE NÃO HÁ INCAPACIDADE ATUAL, COM EXAME PSICOPATOLÓGICO SEM ALTERAÇÕES MAIORES E SEM LIMITAÇÕES OBJETIVAS NOS DOMÍNIOS AVALIADOS (COGNIÇÃO, AUTOCUIDADO, RELACIONAMENTO, ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO).

3. QUAL O PROGNÓSTICO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DA RECLAMANTE? HÁ NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO?

O LAUDO REGISTRA MELHORA PROGRESSIVA APÓS O AFASTAMENTO DO FATOR ESTRESSOR IDENTIFICADO, COM ESTABILIDADE CLÍNICA NO MOMENTO DA PERÍCIA E SEM TRATAMENTO ATIVO ATUALMENTE. ASSIM, O PROGNÓSTICO, À LUZ DO QUE FOI DESCRITO, É FAVORÁVEL, NÃO HAVENDO INDICAÇÃO PERICIAL DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO NO MOMENTO ATUAL, SEM PREJUÍZO DE SEGUIMENTO ASSISTENCIAL CASO HAJA RECIDIVA.

4. CONSIDERANDO O HISTÓRICO LABORAL NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL, ESPECIALMENTE AS ALEGAÇÕES DE REPRESÁLIAS E PRESSÕES APÓS A COMUNICAÇÃO DA GRAVIDEZ, BEM COMO A SITUAÇÃO DE "ÓCIO FORÇADO" APÓS O RETORNO DA LICENÇA-MATERNIDADE, É POSSÍVEL QUE TAIS EVENTOS ATUEM COMO FATORES DESENCADEANTES OU AGRAVANTES PARA O QUADRO PSIQUIÁTRICO DIAGNOSTICADO?

SIM, QUANTO AO "ÓCIO FORÇADO/INATIVIDADE IMPOSTA", O LAUDO EXPLICITAMENTE CONSIDERA QUE, SE COMPROVADO NOS AUTOS O CONTEXTO ORGANIZACIONAL DESCRITO (MANUTENÇÃO PROLONGADA SEM ATRIBUIÇÕES, SEM TAREFAS E SEM JUSTIFICATIVA), TAL SITUAÇÃO PODE SER RECONHECIDA COMO FATOR CONTRIBUTIVO RELEVANTE, EM REGIME DE CONCAUSA (GRAU II), PARA O DESENCADEAMENTO E MANUTENÇÃO DO QUADRO ANSIOSO-ADAPTATIVO. OBSERVA-SE QUE A EXISTÊNCIA DOS FATORES ESTRESSORES MENCIONADOS ESTÁ CONDICIONADA À ACEITAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL PELO JUÍZO, SENDO A CONCLUSÃO DO LAUDO DEPENDENTE DESSA HIPÓTESE FÁTICA.

5. EXISTE NEXO CAUSAL OU, NO MÍNIMO, CONCAUSAL ENTRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O AMBIENTE LABORAL NA RECLAMADA E A PATOLOGIA QUE ACOMETE A RECLAMANTE?

NÃO FOI ESTABELECIDO NEXO CAUSAL DIRETO, NA MEDIDA EM QUE O LAUDO RESSALTA O CARÁTER MULTIFATORIAL DO ADOECIMENTO PSÍQUICO E A IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR O LABOR COMO CAUSA NECESSÁRIA E SUFICIENTE. ENTRETANTO, O LAUDO CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL, COM CONTRIBUIÇÃO MODERADA DO TRABALHO (GRAU II), NOTADAMENTE PELOS RISCOS PSICOSSOCIAIS/ORGANIZACIONAIS

ATRIBUÍDOS À SITUAÇÃO DE “ÓCIO FORÇADO”, CONDICIONANDO-SE A MATERIALIDADE DESSE ESTRESSOR À PROVA ADMITIDA PELO JUÍZO.

6. O LAUDO PSICOLÓGICO ANEXADO (ID. 01F9F2A) DESCREVE QUE OS SINTOMAS DE PÂNICO E ANSIEDADE ERAM DESENCADEADOS ESPECIFICAMENTE PELO DESLOCAMENTO AO TRABALHO. DO PONTO DE VISTA MÉDICO-CIENTÍFICO, ESTE FATO ROBUSTECE A TESE DE QUE A DOENÇA POSSUI NATUREZA OCUPACIONAL? TRATA-SE DE INFORMAÇÃO CLÍNICA QUE SUGERÊ ASSOCIAÇÃO CONTEXTUAL ENTRE O AMBIENTE/ROTINA LABORAL E A ATIVAÇÃO SINTOMÁTICA (CONDICIONAMENTO ANSIÓGENO). NÃO OBSTANTE, ISOLADAMENTE, TAL DADO NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR NEXO CAUSAL. NO CONTEXTO DESTES LAUDOS, ELE SE SOMA À COERÊNCIA TEMPORAL, À MELHORA COM O AFASTAMENTO E AO ENCAMINHAMENTO PELA MÉDICA DO TRABALHO, COMO ELEMENTO DE PLAUSIBILIDADE PARA CONCAUSA, SEM DISPENSAR A NECESSIDADE DE PROVA DO ESTRESSOR ORGANIZACIONAL ALEGADO.

7. A LITERATURA MÉDICA ESPECIALIZADA RECONHECE SITUAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL, ISOLAMENTO E Esvaziamento de funções como fatores de risco psicossocial capazes de levar ao desenvolvimento de transtornos mentais, como os que afligem a reclamante?
SIM. O LAUDO DESCREVE QUE CONDUTAS ORGANIZACIONAIS HOSTIS, INATIVIDADE IMPOSTA, ISOLAMENTO E Esvaziamento funcional podem ser potencialmente geradores de sofrimento psíquico e relaciona tais elementos a riscos psicossociais. TODAVIA, DESTACA QUE A CONFIRMAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E A MATERIALIDADE DOS FATOS DEPENDEM DE PROVA DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL, CABENDO AO JUÍZO A APRECIÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA.

8. ANALISANDO A CRONOLOGIA DOS FATOS — INÍCIO DO CONTRATO EM 14/09/2022 , GESTAÇÃO, LICENÇA-MATERNIDADE COM PARTO EM 25/04/2024 , E O SUBSEQUENTE AFASTAMENTO POR ENCAMINHAMENTO DA PRÓPRIA MÉDICA DA EMPRESA EM 17/11/2024 —, É MEDICAMENTE PLAUSÍVEL ESTABELECEER UMA CORRELAÇÃO ENTRE OS ESTRESSORES OCUPACIONAIS E O SURGIMENTO DA DOENÇA?
SIM. O LAUDO APONTA COERÊNCIA TEMPORAL ENTRE O RETORNO PÓS-LICENÇA (SETEMBRO DE 2024), O INÍCIO DOS SINTOMAS (SETEMBRO/OUTUBRO DE 2024), O INÍCIO DA PSICOTERAPIA (28/10/2024), A EMISSÃO DE ATESTADO PSICOLÓGICO (11/11/2024) E O AFASTAMENTO/ENCAMINHAMENTO PELA MÉDICA DO TRABALHO (17/11/2024), O QUE TORNA PLAUSÍVEL A CORRELAÇÃO EM REGIME DE CONCAUSA, CONDICIONADA À PROVA DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL (“ÓCIO FORÇADO”) ALEGADO.

9. NA DATA DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA, EM 19/02/2025, A RECLAMANTE POSSUÍA CAPACIDADE PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS DE ESPECIALISTA EM RELACIONAMENTO COM O CLIENTE?
NÃO. NA DATA DE 19/02/2025, O PRÓPRIO LAUDO CONSIGNA QUE O CONTRATO FOI ENCERRADO QUANDO A RECLAMANTE ESTAVA AFASTADA, E RECONHECE QUE HOUVE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA NO PERÍODO DO ADOECIMENTO, SENDO QUE A RECUPERAÇÃO/ESTABILIDADE CLÍNICA É DESCRITA APENAS POSTERIORMENTE, NO MOMENTO ATUAL DA AVALIAÇÃO PERICIAL.

10. TENDO EM VISTA QUE A RECLAMANTE OBTVE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA) COM DATA DE INÍCIO DO

BENEFÍCIO (DIB) FIXADA EM 20/01/2025 E DATA DE CESSAÇÃO EM 26/02/2025, PODE-SE AFIRMAR QUE, À ÉPOCA DA SUA DEMISSÃO, ELA SE ENCONTRAVA LEGALMENTE E CLINICAMENTE INCAPACITADA PARA O TRABALHO?

SIM. À ÉPOCA DA DEMISSÃO (19/02/2025), A RECLAMANTE ENCONTRAVA-SE DENTRO DO PERÍODO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIB 20/01/2025 ATÉ 26/02/2025), E O LAUDO RECONHECE QUE HOUE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA RELACIONADA AO EPISÓDIO PSQUIÁTRICO.

11. QUEIRA O(A) SR(A). PERITO(A) ESTIMAR, SE POSSÍVEL, A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORAL DA RECLAMANTE.

COM BASE NO LAUDO, A INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA FOI FORMALMENTE RECONHECIDA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE 20/01/2025 (DIB DO BENEFÍCIO POR MOTIVO PSQUIÁTRICO). NÃO OBSTANTE, O LAUDO REGISTRA AFASTAMENTO E ENCAMINHAMENTO AO INSS PELA MÉDICA DO TRABALHO EM 17/11/2024, DATA QUE SE MOSTRA TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM O INÍCIO DO PERÍODO DE INCAPACIDADE/NECESSIDADE DE AFASTAMENTO, EM COERÊNCIA COM A CRONOLOGIA SINTOMÁTICA DESCRITA.

12. A INCAPACIDADE LABORAL DA RECLAMANTE É DE NATUREZA TOTAL OU PARCIAL? TEMPORÁRIA OU PERMANENTE?

A INCAPACIDADE RECONHECIDA NO LAUDO É TEMPORÁRIA. QUANTO À EXTENSÃO, NO PERÍODO DO AFASTAMENTO, TRATOU-SE DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO LABORAL (BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA), E, NO MOMENTO ATUAL, O LAUDO É CATEGÓRICO EM APONTAR AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL, COM CAPACIDADE PRESERVADA E SEM LIMITAÇÕES OBJETIVAS NOS DOMÍNIOS FUNCIONAIS AVALIADOS.

13. PRESTE O(A) ILUSTRE PERITO(A) QUAISQUER OUTROS ESCLARECIMENTOS QUE JULGUE PERTINENTES PARA A CORRETA ELUCIDAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA E O JUSTO DESLINDE DA CAUSA.

O LAUDO DESTACA QUE O NÚCLEO TÉCNICO DO NEXO, NESTE CASO, NÃO É SOBRECARGA OU PRESSÃO POR METAS, MAS A HIPÓTESE DE “ESVAZIAMENTO FUNCIONAL/INATIVIDADE IMPOSTA” NO RETORNO PÓS-LICENÇA, COM COERÊNCIA TEMPORAL E MELHORA APÓS AFASTAMENTO. NÃO OBSTANTE, A MATERIALIDADE DESSE ESTRESSOR ORGANIZACIONAL É CONDICIONADA À PROVA DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL ADMITIDA PELO JUÍZO, CONFORME EXPRESSAMENTE REGISTRADO NO LAUDO, RAZÃO PELA QUAL A CONCLUSÃO CONCAUSAL DEVE SER LIDA SOB ESSA PREMISSA PROBATÓRIA.

DA RECLAMADA

1. DESCREVA O SR. PERITO AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA RECLAMANTE NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE ESPECIALISTA RELACIONAMENTO CLIENTE I, INICIADAS EM 14/09/2022 E ENCERRADAS EM 19/02/2025, DANDO ÊNFASE AO PERÍODO EM QUE ALEGA DESENCADear A PATOLOGIA PSÍQUICA.

CONFORME O LAUDO, A RECLAMANTE EXERCIA A FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM RELACIONAMENTO COM O CLIENTE I, COM JORNADA DE 6H20 E TRÊS PAUSAS. O TRABALHO FOI DESCRITO COMO PRESENCIAL INICIALMENTE (TRÊS MESES) E POSTERIORMENTE EM HOME OFFICE; HÁ REGISTRO DE QUE, DURANTE A GESTAÇÃO, TERIA RETORNADO AO PRESENCIAL. A ÊNFASE PERICIAL, CONTUDO, FOI DIRIGIDA AO

PERÍODO PÓS-LICENÇA MATERNIDADE (RETORNO EM SETEMBRO DE 2024), QUANDO A RECLAMANTE RELATA “ÓCIO FORÇADO”, COM COMPARECIMENTO DIÁRIO, REGISTRO DE PONTO E AUSÊNCIA DE ACESSOS/LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS.

2. OS FATOS NARRADOS NA INICIAL DEMONSTRAM EFETIVA PRESSÃO PSÍQUICA, EM FREQUÊNCIA E INTENSIDADE CAPAZES DE DESENCADear A DOENÇA PSÍQUICA DESCRITA NA INICIAL?

O LAUDO REGISTRA QUE NÃO SE TRATA, NA ANÁLISE TÉCNICA, DE SOBRECARGA, METAS ABUSIVAS OU PRESSÃO POR DESEMPENHO, E SIM DA HIPÓTESE DE “ESVAZIAMENTO FUNCIONAL/INATIVIDADE IMPOSTA” (“ÓCIO FORÇADO”), POTENCIALMENTE GERADORA DE SOFRIMENTO PSÍQUICO. ENTRETANTO, A CARACTERIZAÇÃO DESSE “ÓCIO FORÇADO” COMO FATO OBJETIVO É EXPRESSAMENTE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL NOS AUTOS, NÃO SENDO POSSÍVEL, SEM ESSA PROVA, AFIRMÁ-LO COMO ESTRESSOR ORGANIZACIONAL MATERIALMENTE CONFIGURADO.

3. ALGUMA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA RECLAMANTE DIFERE DAQUELAS PARA AS QUAIS FOI CONTRATADA E TREINADA?

O LAUDO NÃO DESCREVE DESVIO OU ACÚMULO DE FUNÇÃO. AO CONTRÁRIO, CONSIGNA QUE RECEBEU TREINAMENTO ADEQUADO E NÃO RELATA ALTERAÇÃO TÍPICA DE ATRIBUIÇÕES COMO ELEMENTO CENTRAL DO CASO, SENDO O PONTO NUCLEAR A ALEGADA INATIVIDADE/ESVAZIAMENTO DE TAREFAS NO RETORNO PÓS-LICENÇA.

4. ANSIEDADE É UM SENTIMENTO VAGO E DESAGRADÁVEL DE MEDO, APREENSÃO, CARACTERIZADO POR TENSÃO OU DESCONFORTO DERIVADO DE ANTECIPAÇÃO DE PERIGO, DE ALGO DESCONHECIDO OU ESTRANHO? SÃO OS QUADROS PSIQUIÁTRICOS MAIS COMUNS TANTO EM CRIANÇAS QUANTO EM ADULTOS, COM UMA PREVALÊNCIA ESTIMADA DURANTE O PERÍODO DE VIDA DE 9% E 15% RESPECTIVAMENTE?

QUESITO GENÉRICO, DOUTRINÁRIO E NÃO DIRETAMENTE SUBSUMÍVEL À OBJETIVAÇÃO PERICIAL DO CASO CONCRETO (DIAGNÓSTICO, NEXO E REPERCUSSÃO FUNCIONAL), RAZÃO PELA QUAL NÃO É RESPONDIDO COMO ASSERTIVA EPIDEMIOLÓGICA NESTE LAUDO, NOS TERMOS DO CPC QUANTO À PERTINÊNCIA AO OBJETO DA PERÍCIA. NO CASO CONCRETO, O LAUDO TRABALHA COM O DIAGNÓSTICO E A DINÂMICA CLÍNICA ESPECÍFICA DESCRITA (TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO F43.2, COM MENÇÃO A F41.1 EM RELATÓRIOS ASSISTENCIAIS).

5. O PACIENTE PSIQUIÁTRICO TEM UM MODO SINGULAR DE ENXERGAR O MUNDO, OS OUTROS E A SI MESMO, APRESENTA DISTORÇÕES COGNITIVAS, FILTRA AS INFORMAÇÕES SEMPRE DE FORMA PESSIMISTA E NEGATIVA, O QUE AFETA DE MANEIRA SIGNIFICATIVA SUA VIDA?

QUESITO GENÉRICO E ESTEREOTIPADO, NÃO COMPATÍVEL COM A METODOLOGIA PERICIAL DO CASO CONCRETO. NO EXAME PSICOPATOLÓGICO DESCRITO NO LAUDO, A RECLAMANTE APRESENTOU DISCURSO COERENTE, PENSAMENTO COM CURSO E CONTEÚDO PRESERVADOS, JUÍZO CRÍTICO E INSIGHT PRESERVADOS, SEM EVIDÊNCIA DE DISTORÇÕES COGNITIVAS PERSISTENTES COMO TRAÇO DEFINIDOR, HAVENDO APENAS EMOCIONALIDADE AO RELATAR VIVÊNCIAS LABORAIS E HUMOR ALGO HIPOTÍMICO.

6. A DOENÇA MENTAL E COMPORTAMENTAL ALEGADA NA INICIAL, NÃO TEM COMO CAUSA AS ATIVIDADES LABORAIS, JÁ QUE A MESMA TEM ORIGEM MULTIFATORIAL

E, PORTANTO, NÃO EXISTE RELAÇÃO COM O TRABALHO, MAS SIM VULNERABILIDADE BIOLÓGICA?

NÃO. O LAUDO RECONHECE A MULTIFATORIALIDADE COMO REGRA EM PSIQUIATRIA E, EXATAMENTE POR ISSO, NÃO CONCLUI POR NEXO CAUSAL DIRETO. ENTRETANTO, CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL (GRAU II), COM CONTRIBUIÇÃO MODERADA DO TRABALHO, EM INTERAÇÃO COM FATOR PSÍQUICO INDIVIDUAL, NOTADAMENTE SOB A HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DO ESTRESSOR ORGANIZACIONAL ("ÓCIO FORÇADO") DESCRITO.

7. CONFIRMA O SR. PERITO QUE A DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE EM "ÓCIO FORÇADO" OU "PRESSÃO PSICOLÓGICA" NÃO SE CONFIRMA? A RECLAMANTE NÃO SE APRESENTOU A RECLAMADA DECLARANDO- SE APTA AO TRABALHO E QUE SEU RETORNO TENHA SIDO ARBITRARIAMENTE RECUSADO?

NÃO É POSSÍVEL CONFIRMAR, NESTE LAUDO, A NEGATIVA FÁTICA CATEGÓRICA CONTIDA NO QUESITO. O LAUDO REGISTRA A NARRATIVA DE "ÓCIO FORÇADO" COMO ELEMENTO CENTRAL, MAS EXPRESSAMENTE CONDICIONA SUA CARACTERIZAÇÃO OBJETIVA À PROVA DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL (REGISTROS DE ACESSO, COMUNICAÇÕES INTERNAS, ORDENS DE SERVIÇO OU EQUIVALENTES) A SER APRECIADA PELO JUÍZO. ASSIM, SEM PROVA MATERIAL ADMITIDA, O TEMA PERMANECE NO CAMPO SUBJETIVO DA ANAMNESE, NÃO PODENDO SER NEM AFIRMADO NEM NEGADO COMO FATO OBJETIVO DE FORMA AUTÔNOMA PELO PERITO.

8. A RECLAMANTE TEM QUESTÕES DE ORDEM PESSOAL OU FAMILIAR (COMO MÃE COM DEPRESSÃO, PAI COM QUADRO DE DEPENDÊNCIA POR ÁLCOOL E IRMÃO COM ESQUIZOFRENIA) QUE POSSAM TER CONTRIBUÍDO NO DESENCADEAMENTO DA PATOLOGIA?

NÃO. O LAUDO CONSIGNA AUSÊNCIA DE HISTÓRIA PATOLÓGICA FAMILIAR CONHECIDA PARA TRANSTORNOS MENTAIS E NÃO DESCREVE, NA ANAMNESE, OS ELEMENTOS FAMILIARES ESPECÍFICOS CITADOS NO QUESITO COMO FATORES CONTRIBUTIVOS.

9. O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UMA HERDABILIDADE SIGNIFICATIVA CONTRIBUIU PARA O ENTENDIMENTO DO PROBLEMA COMO UMA DOENÇA ESPECÍFICA COM ORIGEM BIOLÓGICA E, PORTANTO, NÃO RELACIONADA AO TRABALHO?

NÃO. O LAUDO, AO DISCUTIR GENÉTICA, RESSALTA A INTERAÇÃO COMPLEXA ENTRE VULNERABILIDADE INDIVIDUAL E AMBIENTE, NÃO AUTORIZANDO CONCLUSÃO AUTOMÁTICA DE "NÃO RELAÇÃO COM O TRABALHO" APENAS POR EXISTIR COMPONENTE BIOLÓGICO. AO CONTRÁRIO, A LÓGICA PERICIAL ADOTA A MULTIFATORIALIDADE COMO PREMISA E ADMITE CONCAUSA QUANDO HÁ FATOR LABORAL CONTRIBUTIVO IDENTIFICÁVEL, CONDICIONADO À PROVA DO ESTRESSOR.

10. HÁ COMPROVAÇÃO EFETIVA DE "PRESSÃO PSÍQUICA REITERADA" OCORRIDA NO TRABALHO, CAPAZ DE DESENCADear CRISES DE ANSIEDADE?

O LAUDO NÃO IDENTIFICA, COMO NÚCLEO DO CASO, "PRESSÃO REITERADA" POR METAS OU SOBRECARGA. O FATOR LABORAL RELEVANTE DISCUTIDO FOI A HIPÓTESE DE INATIVIDADE IMPOSTA ("ÓCIO FORÇADO") NO PÓS-LICENÇA, CUJA MATERIALIDADE É CONDICIONADA À PROVA DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL. ASSIM, A COMPROVAÇÃO "EFETIVA", COMO FATO OBJETIVO, DEPENDE DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SER ADMITIDO E VALORADO PELO JUÍZO.

11. CONCLUA O SR. PERITO SE HÁ NEXO CAUSAL / CONCAUSAL ENTRE A DOENÇA E AS ATIVIDADES LABORATIVAS QUE A RECLAMANTE DESENVOLVEU NA RECLAMADA, DURANTE SEU CONTRATO DE TRABALHO, APRESENTANDO SUAS RAZÕES.

NÃO HÁ NEXO CAUSAL DIRETO. HÁ NEXO CONCAUSAL, COM CONTRIBUIÇÃO MODERADA DO TRABALHO (GRAU II), POR PLAUSIBILIDADE CIENTÍFICA E COERÊNCIA TEMPORAL ENTRE O RETORNO PÓS-LICENÇA, O INÍCIO DOS SINTOMAS, O AFASTAMENTO PELA MÉDICA DO TRABALHO E A MELHORA APÓS AFASTAMENTO, ESPECIALMENTE SOB A HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DO “ÓCIO FORÇADO” COMO ESTRESSOR PSICOSSOCIAL/ORGANIZACIONAL. OBSERVA-SE QUE A EXISTÊNCIA DOS FATORES ESTRESSORES MENCIONADOS ESTÁ CONDICIONADA À ACEITAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E/OU TESTEMUNHAL PELO JUÍZO, SENDO A CONCLUSÃO CONCAUSAL DEPENDENTE DESSA PREMISSA FÁTICA.

12. QUAL A SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATUAL DA RECLAMANTE?

CONFORME O LAUDO, HOVE BENEFÍCIOS NA ESPÉCIE 31 EM 11/03/2024 A 24/04/2024 (PIELONEFRITE) E 20/01/2025 A 26/02/2025 (MOTIVO PSIQUIÁTRICO). NO MOMENTO ATUAL DESCRITO NO LAUDO, A RECLAMANTE ESTÁ CLINICAMENTE ESTÁVEL, SEM TRATAMENTO ATIVO, NÃO HAVENDO REGISTRO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATIVO.

13. APÓS A DEMISSÃO DA RECLAMADA, LABOROU A RECLAMANTE EM OUTRAS EMPRESAS / INFORMAL?

SIM. O LAUDO REGISTRA VÍNCULO POSTERIOR COM “ATAKAREJO”, COM ADMISSÃO EM 11/2025, NA FUNÇÃO DE OPERADOR.

Do Magistrado
NÃO HOVE

Salvador, 19 de dezembro de 2025.

É o laudo pericial.

Dr. Marco Foltran
CRM 7833 CE – Perícia Médica

Os Peritos estão sujeitos à disciplina judiciária, sendo considerados auxiliares da Justiça para auxiliar a solucionar questões que exigem conhecimentos específicos em determinadas matérias. Função de natureza pública, assumindo presunção *jure et de jure*, e podem ser contraditados quando de provas incontroversas, não pelo simples inconformismo com a conclusão.